

Cas Cliniques QCM

Cas clinique 1 :

Patient âgé de 68 ans, aux antécédents d'HTA et de diabète, consulte pour une lourdeur de l'hémicorps gauche avec trouble du comportement d'installation brutale évoluant depuis 7 heures. L'examen clinique initiale aux urgences a objectivé une hémiparésie gauche à prédominance crurale, une apathie, une TA= 170/80 mmHg et une glycémie à 1,3g/l. Le scanner cérébral a objectivé une hypodensité dans le territoire de l'artère cérébrale antérieure droite.

1/ Quels sont les autres signes cliniques à rechercher chez ce patient :

- A. Aphasie de Wernicke
- B. Grasping reflexe à gauche
- C. Anosognosie gauche
- D. Hémianesthésie gauche à prédominance crurale
- E. Hémiasomatognosie gauche

2/ Chez ce patient, à la phase aigüe, la CAT consiste à :

- A. Un contrôle des chiffres tensionnels avec objectif de la TA<140/90 mmhg
- B. Une thrombolyse en IV par rt-PA
- C. Une héparinothérapie à dose curative
- D. Une oxygénothérapie si SaO₂ < 95%
- E. Une insulinothérapie si dextro > 1,8 g/l

3/ Chez ce patient, parmi les étiologies de son AVC ischémique, on évoque :

- A. La fibrillation auriculaire
- B. L'athérosclérose au niveau du tronc basilaire
- C. La microangiopathie hypertensive
- D. L'angiopathie amyloïde cérébrale
- E. Une dissection vertébrale

Cas clinique 2 :

Patient âgé de 72 ans, aux antécédents de diabète, HTA, goutte, artériopathie des membres inférieurs, tabagique à 70 PA, consulte à H12 pour une hémiparésie gauche à prédominance brachiofaciale de survenue brutale associée à une déviation réductible de la tête et des yeux à droite et une hémiparésie gauche. Le scanner cérébral a montré une hypodensité temporo-pariétale droite.

1/ Parmi les facteurs de risque cardio-vasculaire modifiables chez ce patient, on retient :

- A. L'âge
- B. Le sexe
- C. Le diabète
- D. L'HTA
- E. La goutte

2/ Le territoire vasculaire de cet accident cérébral ischémique est l'artère :

- A. Choroïdienne antérieure droite
- B. Vertébrale droite
- C. Cérébrale postérieure droite
- D. Cérébrale antérieure droite
- E. Cérébrale moyenne droite

3/ Quels sont les autres signes cliniques à rechercher chez ce patient :

- A. Une aphasie de Broca
- B. Une HLH gauche
- C. Une anosognosie gauche

- D. Une hémianesthésie gauche à prédominance crurale
- E. Une hémiasomatognosie gauche

4/ Ce patient a présenté il y a un mois une hémiparésie gauche à prédominance brachio-faciale et des troubles de l'élocution régressifs au bout de 20 minutes. IRM cérébrale a été faite et n'a pas objectivé d'anomalies. Les diagnostics plausibles sont :

- A. Un accident vasculaire cérébral constitué
- B. Un accident ischémique transitoire
- C. Une crise épileptique focale
- D. Une aura migraineuse
- E. Une transformation hémorragique de son AVC ischémique

Cas clinique 3 :

Patiente âgée de 29 ans, G2P2A0, sous pilule contraceptive oestroprogestative, consulte pour des céphalées avec baisse de l'acuité visuelle évoluant depuis 5 jours. Le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale du sinus latéral gauche a été retenu après explorations.

1/La thrombose veineuse cérébrale du sinus latéral gauche isolé peut se manifester par :

- A. Une dysarthrie
- B. Une atteinte du VI
- C. Une atteinte du VIII
- D. Un tableau d'HTIC
- E. Des céphalées

2/L'examen de référence pour confirmer le diagnostic positif d'une thrombose veineuse cérébrale est :

- A. La ponction lombaire
- B. Les D-dimères
- C. L'IRM cérébrale avec angio-IRM veineuse
- D. Un scanner cérébral sans injection du produit de contraste
- E. L'artériographie veineuse

3/ En cas d'extension de la thrombose veineuse cérébrale du sinus latéral gauche vers le sinus sagittal supérieur, le scanner cérébral sans injection de produit de contraste peut montrer :

- A. Le signe de la belle artère sylvienne
- B. Le signe de la corde
- C. Le signe de triangle dense
- D. Le signe de delta vide
- E. L'effacement des sillons corticaux

Cas clinique 4 :

Patiente âgée de 76 ans, hospitalisée depuis 3 jours en médecine interne pour prise en charge d'une thrombose veineuse profonde du membre inférieur gauche sous héparine à bas poids moléculaire dose curative. Au cours de l'hospitalisation elle présente un trouble de langage et une lourdeur de l'hémicorps droit d'installation brutale à 12h. L'examen clinique objective une hémiparésie droite à prédominance brachio-faciale, une aphasie non fluente, TA 160/90mm Hg et dextro à 1,1 g/l. Le scanner cérébral réalisé à H3 du déficit n'a pas montré d'anomalies.

1/Cet accident cérébral siège dans le territoire vasculaire de l'artère :

- A. Cérébrale moyenne gauche

- B. Vertébrale gauche
 - C. Choroïdienne antérieure gauche
 - D. Cérébrale antérieure gauche
 - E. Cérébrale postérieure gauche
2. Le protocole d'urgence d'IRM cérébrale à la phase aigüe d'un AVC ischémique comporte les séquences suivantes :
- A. T2/FLAIR
 - B. Perfusion
 - C. Diffusion
 - D. T2* écho de gradient
 - E. 3D TOF
- 3/ l'IRM cérébrale a objectivé un mismatch Diffusion/FLAIR. Cette patiente doit bénéficier en urgence :
- A. D'un comprimé d'AVK
 - B. D'une thrombolyse par rtPA en intraveineux
 - C. D'une hospitalisation dans une unité neurovasculaire
 - D. D'une double anti-agrégation plaquettaire
 - E. D'un traitement antihypertenseur par voie veineuse

Cas clinique 5 :

Patiente âgée de 45 ans, droitère, aux antécédents de double remplacement valvulaire mitral et aortique sous AVK depuis 7 ans. Elle consulte pour un flou visuel de l'œil gauche de survenue brutale à 17H. Elle consulte à H2 du tableau clinique. A l'examen : hémianopsie latérale homonyme gauche, TA= 160/80 mmHg, dextro=2,5g/l. IRM cérébrale montre un hypersignal diffusion occipital droit qui n'est pas présent sur la séquence T2 flair avec absence de signe de saignement à la séquence T2 echo de gradient :

1/Quels sont les autres signes cliniques à rechercher chez cette patiente :

- A. Aphasie de Broca
- B. Trouble de la représentation spatiale
- C. Prosopagnosie
- D. Hémiparésie gauche totale et proportionnelle
- E. Hémiasomatognosie gauche

2/Chez cette patiente, la thrombolyse par le rt-PA en IV est contre-indiquée en cas :

- A. D'endocardite infectieuse
- B. Un INR>1,7
- C. Un taux de plaquettes<100000
- D. Présence d'un hypersignal diffusion à l'IRM cérébrale
- E. Un ulcère gastro-duodénal traité

3/ A distance de la phase aigüe et dans le cadre de la prévention secondaire cette patiente devrait bénéficier :

- A. D'un traitement antiagrégant plaquettaire
- B. D'une double antiagrégant plaquettaire
- C. D'une anticoagulation curative
- D. D'équilibration de son diabète avec comme objectif HbA1C<6 %
- E. D'une équilibration de son HTA avec comme objectif TA<160/90 mmHg

Cas clinique 6 :

Patient âgé de 36 ans, droitier, travaillant comme maçon, consulte aux urgences pour une lourdeur de l'hémicorps gauche d'installation brutale. L'examen clinique retrouve une hémiparésie gauche à prédominance brachio-faciale, une hémiasomatognosie gauche, TA = 130/80 mm Hg, GAD = 1 g/l. Les explorations radiologiques concluent à un AVC ischémique dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne droite secondaire à une dissection artérielle.

1. Quels sont les autres signes cliniques à rechercher chez ce patient :
 - A. Aphasie de Broca
 - B. Dysarthrie
 - C. Anosognosie
 - D. Hémihypoesthésie gauche à prédominance brachio-faciale
 - E. Hémiparésie gauche
2. Cet accident vasculaire cérébral ischémique peut être secondaire à une dissection au niveau de l'artère :
 - A. Vertébrale droite
 - B. Carotide interne gauche
 - C. Carotide interne droite
 - D. Vertébrale gauche
 - E. Carotide externe droite
3. Quels sont les éléments à rechercher qui orientent vers une dissection artérielle chez ce patient :
 - A. Traumatisme cervical ou crânien précédant le déficit
 - B. Acouphènes pulsatiles à droite
 - C. Palpitations cardiaques précédant le déficit
 - D. Signe de Claude Bernard Horner à droite
 - E. Cervicalgies associées

Cas clinique 7 :

Patient âgé de 78 ans, aux antécédents d'HTA, AVC hémorragique lobaire pariétal droit il y'a 3 ans et des troubles mnésiques évoluant depuis 2 ans. Il consulte à H3 pour des céphalées de survenue brutale associées à une hémiparésie droite. L'examen à la salle d'urgence montre : TA=170/100 mmHg, dextro=1,3 g/l, température =36,6°.

1/ Les diagnostics possibles chez ce patient :

- A. Un AVC hémorragique
- B. Un déficit post critique
- C. Un AVC ischémique
- D. Une hypoglycémie
- E. Une AVC ischémique transitoire

2/ Le scanner cérébral sans injection de produit de contraste a montré la présence d'une hyperdensité lobaire frontale gauche. Ce patient doit bénéficier en urgence des mesures suivantes :

- A. D'une hospitalisation dans une unité neurovasculaire
- B. D'une administration rapide de PPSB et vitamine K
- C. D'une thrombolyse intra veineuse par rt-PA
- D. D'un respect des chiffres tensionnels
- E. D'un test de trouble de la déglutition

3/ Quelle est l'étiologie la plus probable de l'AVC chez ce patient :

- A. Une microangiopathie hypertensive

- B. Une rupture d'une malformation artério veineuse
- C. L'athérosclérose
- D. L'angiopathie amyloïde
- E. Une rupture d'un anévrysme artériel

Cas clinique 8 :

Patient âgé de 52 ans aux antécédents de remplacement valvulaire mitral avec fibrillation auriculaire sous AVK. Consulte les urgences pour constatation au réveil de céphalées et troubles de l'équilibre. L'examen montre une dysarthrie et un syndrome cérébelleux droit. IRM cérébrale réalisée en urgence montre un hypersignal droit de l'hémisphère cérébelleux sur la séquence de diffusion avec restriction de l'ADC qui n'est pas présent sur la séquence T2 Flair et sans stigmate de saignement sur la séquence T2 echo de gradient. Ture= 37°. TA =160/95 mmHg, GAD=1,3g, INR=1,5.

1/Chez ce patient, la conduite à tenir en urgence consiste à :

- A. Un contrôle des chiffres tensionnels avec objectif TA<130/90 mmhg
- B. Une thrombolyse en IV par rt-PA
- C. Double anti-agrégation : Aspégic et Clopidogrel
- D. Héparinothérapie dose curative
- E. Une insulinothérapie en sous cutané

2/Cet accident cérébral siège dans le territoire vasculaire de l'artère :

- A. Cérébrale moyenne droite
- B. Choroïdienne antérieure droite droite
- C. Cérébelleuse postéroinférieure
- D. Cérébrale antérieure droite
- E. Cérébrale postérieure droite

3/ Chez ce patient, le LDL cholestérol= 1,5g/l. Le traitement préventif au long cours chez ce patient consiste à la mise sous :

- A. Anticoagulants oraux directs
- B. Antivitamine K
- C. Antiagrégant plaquettaire
- D. Héparine de faible poids moléculaire
- E. Statine

QCM**QCM 1**

Un AVC ischémique dans le territoire vertébro-basilaire peut se traduire par :

- A. Une anosognosie
- B. Une hémianopsie latérale homonyme
- C. Une Hémiplégie à prédominance crurale
- D. Une aphasie de Wernicke
- E. Un syndrome alterne

QCM 2

La séquence T2 écho de gradient de l'IRM cérébrale lors d'un AVC ischémique permet :

- A. D'identifier la leucopathie vasculaire
- B. De visualiser l'occlusion artérielle
- C. De visualiser l'infarctus cérébral au bout de 30 minutes
- D. De visualiser toute lésion hémorragique intra parenchymateuse
- E. D'étudier des branches du polygone de Willis

QCM 3

La prévention secondaire de l'AVC ischémique en rapport avec une athérosclérose consiste à la prescription :

- A. De statines (objectif : LDL-cholestérol < 0,7 g/l)
- B. D'anticoagulants directs
- C. D'antidiabétiques avec un objectif : HbA1c < 6,5 %
- D. D'antihypertenseurs avec un objectif : PA < 120/70 mmHg
- E. D'une activité physique régulière

QCM 5

Un accident ischémique transitoire peut se traduire cliniquement par :

- A. Une cécité unilatérale isolée
- B. Une Tétraparésie flasque
- C. Une aphasie isolée
- D. Un état de mal épileptique
- E. Une héli hypoesthésie et une dysarthrie

QCM 6

Quels sont les signes cliniques qui orientent vers un infarctus sylvien superficiel de l'hémisphère dominant ?

- A. Une aphasie de Broca
- B. Une aphasie de Wernicke
- C. Une apraxie idéomotrice
- D. Une héminégligence
- E. Une anosognosie

QCM 7

Quels sont les tableaux cliniques possibles d'un infarctus lacunaire ?

- A. Une hémiplégie motrice pure
- B. Une hémianesthésie pure
- C. Une dysarthrie-main malhabile
- D. Un déficit sensitivo-moteur proportionnel
- E. Un syndrome alterne

QCM 8

Quels sont les signes cliniques du syndrome de Wallenberg ?

- A. Syndrome de Claude Bernard-Horner
- B. Hémi-syndrome cérébelleux homolatéral
- C. Paralysie faciale périphérique homolatérale
- D. Troubles de la déglutition et dysphonie
- E. Anesthésie thermo-algique controlatérale touchant la face

QCM 9

Quelles sont les principales étiologies des AVC ischémiques du sujet jeune ?

- A. Une dissection carotidienne ou vertébrale
- B. Une valvulopathie rhumatismale
- C. Une angiopathie amyloïde
- D. Une angéite cérébrale
- E. Des anomalies de l'hémostase

QCM 10

Quels sont les éléments cliniques évocateurs d'une thrombose du sinus caverneux ?

- A. Une paralysie oculomotrice douloureuse
- B. Une hypoesthésie dans le territoire de la branche ophtalmique du trijumeau
- C. Une exophtalmie
- D. Un ptosis
- E. Un chémosis

QCM 11

Un accident vasculaire cérébral ischémique du territoire de l'artère choroïdienne antérieure gauche peut se manifester par :

- A. Une hémiparésie droite
- B. Un syndrome d'héminégligence.
- C. Une hémi hypoesthésie droite
- D. Une aphasie de Wernicke
- E. Une hémianopsie homonyme homolatérale droite

QCM 12

Quels sont les signes cliniques qui orientent vers une atteinte de l'artère cérébrale antérieure ?

- A. Une hémiplégie à prédominance crurale
- B. Des troubles du langage
- C. Une hémianopsie latérale homonyme
- D. Une apathie ou mutisme
- E. Des troubles sphinctériens

QCM 13

Parmi les contre-indications à la thrombolyse intraveineuse dans les AVC ischémiques, on retient :

- A. Le signe de la très belle artère sylvienne sur le scanner cérébral
- B. Un acte chirurgical datant de plus de 1 an
- C. Un taux de plaquettes $< 100\,000 /\text{mm}^3$
- D. Une pression artérielle $< 185/110 \text{ mmHg}$
- E. Un patient âgé de plus de 80 ans

QCM 14

Quels sont les objectifs de la prise en charge en unité neurovasculaire (UNV) ?

- A. Une surveillance clinique et paraclinique rapprochée
- B. Une réduction du risque de complications à la phase aigüe
- C. Une diminution du taux de mortalité
- D. Une réhabilitation et une rééducation précoces
- E. Une prévention des récives des AVC à la phase aigue